| 5.2 취약환자 권리보호 | | | |
|---|---|---|---|
| 규 정 번 호 | 5.2 | 제 정 일 | |
| 관련 인증기준 | 5.2 취약환자 권리보호 | 최근 개정일 | |
| 담 당 부 서 | 간호부, 원무과 | 시 행 일 | |
| 검 토 책 임 자 | 병원 운영위원회 | 검 토 주 기 | 2년 |
| 승 인 책 임 자 | 병원장 | 검토 예정일 | |
| 관 련 근 거 | 1. 노인복지법, 2. 성폭력 방지 및 피해자 보호 등에 관한 법률<br>3. 가정폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법, 4. 장애인 노인 임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률 시행규칙 | | |

## ▣ 목적 (Purpose)

취약환자를 정의하고, 해당 환자의 권리를 보호하기 위한 절차를 수립한다. 직원들은 취약환자에 대한 의료기관의 책임과 지원체계를 이해하기 위함이다.

## ▣ 용어 정의 (Definition)

- 취약환자 : 학대 및 폭력피해자(의료기관 내 피해자 포함), 장애환자, 의사소통이 어려운 환자 등으로 각 관련법에 근거.
- 아동학대 : 보호자를 포함한 성인이 아동의 건강 또는 복지를 해치거나 정상적 발달을 저해할수 있는 신체적 · 정신적 · 정서적 · 성적 폭력이나 가혹행위를 하는 것과 보호자가 아동을유기하거나 방임하는 것을 말한다.
- 노인학대 : 노인에 대하여 신체적 · 정신적 · 정서적 · 성적 폭력 및 경제적 착취 또는 가혹행위를 하거나 유기 또는 방임하는 것 (노인복지법 제39조의 6 제2항 제 1호)
- 성폭력피해자 : 상대방의 동의 없이 강제적으로 성적 행위를 하거나, 유사 행위로 인해 신체적 정신적 피해를 받은 자 (성폭력 방지 및 피해자 보호 등에 관한 법률 제2조)
- 가정폭력피해자 : 가정폭력으로 인하여 직접적으로 피해를 입은 자 (가정폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 제 2조)
- 장애환자 : 신체적 또는 정신적 장애로 인해 일상적인 활동에 제약을 받는 사람으로 진단을 받은 환자 (장애인 복지법 제2조)
- 지원체계 : 관련법에 근거한 외부 보고, 정신 및 심리상담, 유기관 연계, 사회사업연계 필수검사 및 신체검진 등 (노인복지법 제39조의 6)

## ▣ 정책 (Policy)

1. 취약환자의 권리보호에 대한 규정이 있다.
2. 직원은 의사소통이 어려운 환자를 위한 지원체계를 알고 있다.
3. 직원은 학대 및 폭력피해자 발생 시 절차를 준수한다.
4. 학대 및 폭력피해자 발생 시 경영진에게 보고하고 개선활동을 수행한다.
5. 학대 및 폭력 예방활동을 수행한다.
6. 직원은 학대 및 폭력 대응체계, 예방활동에 관한 교육을 받고, 그 내용을 이해한다.
7. 학대 및 폭력 신고절차에 대해 안내한다.

8. 거동이 불편한 환자의 편의를 위한 시설을 구비하고, 직원은 이를 알고 있다.

**▣ 지침 및 절차 (Guidelines & Process)**

**1. 취약환자의 정의**

**가. 취약환자란 학대(아동, 노인학대 등) 및 폭력피해자(성폭력, 가정폭력)와 의료기관 내 학대 및 폭력을 당한 피해자를 포함하고 의사소통이 어려운 환자 등이며 취약환자가 발생 하여 타 부서에서 접수 의뢰 할 경우 취약환자 접수대장에 기록하고 상담을 실시하여 기록한다.**

**2. 의사소통이 어려운 환자를 위한 지원체계**

**가. 대상자 : 청각 · 언어 장애인 등 의사소통이 어려운 환자**

**나. 지원 : 취약환자 지원부서 및 관계기관 활용**

1) 취약환자 지원부서(원무과-사회복지사)

가) 청각장애 환자인 경우 구화 나 필담으로 의사소통을 하며, 환자와 의료진 간 원활한 의사소통을 돕기 위하여 전문수화통역센터(손말이음, https://107.relaycall.or.kr/, ☎107)을 마련하여 진료시 불편함이 없도록 한다.

나) 시각장애 환자인 경우 직원은 모든 정보와 교육을 제공할 때 반드시 구두로 설명한다.

다) 의사소통이 어려운 외국인 환자인 경우 사회복지사에게 의뢰하고 사회복지사는 안내 및 통역지원을 위해 BBB통역센터(1588-5644)를 활용한다.

2) 취약환자 관계기관

<table>
<tr><th>취약환자</th><th>지원부서 및 전화번호</th><th>관계기관 및 전화번호</th></tr>
<tr><td rowspan="3">의사소통이 어려운자<br>(청각, 언어 장애인)</td><td rowspan="4">☞ 주간 :<br>- 원무과-사회복지사<br>☎02-575-5114(내선910)<br>☞ 야간 :<br>- 당직의<br>☎(의사 당직근무표 참조)</td><td>손말이음(107)<br>https://107.relaycall.or.kr</td></tr>
<tr><td>강남장애인복지관<br>강남구수어통역센터<br>1)영상전화:070-7947-0036<br>010-4131-6798<br>2)사무실전화:02-451-6798</td></tr>
<tr><td>서울특별시 시각장애인복지관<br>02-422-8108</td></tr>
<tr><td>외국인 환자</td><td>BBB통역센터(1588-5644)</td></tr>
</table>

**다. 직원 교육**

1) 취약환자의 권리와 안전보장을 위한 교육을 전 직원을 대상으로 연 1회 실시한다.

2) 교육은 서면 교육, 집체 교육, 온라인 교육 등으로 가능하다.

**라. 환자 및 보호자 정보제공**

1) 병원 게시판 등을 통해 취약환자를 위한 지원체계에 대해 정보제공한다.

**3. 학대(아동, 노인학대 등) 및 폭력피해자(성폭력, 가정폭력 등) 발생 시 대응체계**

**가. 대상자 : 관련법에 근거한 아동학대, 노인학대, 성폭력, 가정폭력 등**

**나. 관련법에 근거한 신고절차**

1) 아동학대 신고절차(아동학대범죄의 처벌 등에 관한 특례법 제 10조)

가) 관련법에 따라 아래 해당하는 자는 그 직무상 아동학대범죄를 알게 된 경우나 그 의심이 있을 경우 즉시 주간에는 사회복지사에게, 야간 및 휴일에는 당직의사에게 보고한다.

(1) 의료기관의 장

(2) 의료인

(3) 의료기사(방사선사, 물리치료사, 재활치료사 등)

나) 보고받은 사회복지사 또는 당직의사는 행정부장에게 즉시 보고하고, 행정부장은 병원장에게 보고하며 아동학대신고는 서울동남아동보호전문기관(☎02-474-1391)로 전화하거나 수사기관(☎112)로 신고한다.

2) 노인학대 신고절차(노인복지법 제39조의6)

가) 관련법에 따라 아래 해당하는 자는 그 직무상 65세 이상의 사람에 대한 노인학대를 알게 된 때에는 즉시 주간에는 사회복지사, 야간에는 당직의사에게 보고한다.

(1) 의료기관의 의료인 및 의료기관의 장

(2) 의료기사(방사선사, 물리치료사, 재활치료사 등)

(3) 의료기관 종사자

나) 보고 받은 사회복지사 또는 당직의사는 행정부장에게 즉시 보고하고, 행정부장은 병원장에게 보고하며 노인학대의 신고는 중앙노인보호전문기관(☎1577-1389)로 전화 하거나 수사기관(☎112)로 신고한다.

3) 성폭력 신고절차(성폭력방지 및 피해자 보호등에 관한 법률 제 9조)

가) 직원은 19세 미만의 미성년자의 성폭력의 사실을 알게 되었거나 만 19세 이상의 성폭력 피해자는 신고 의사를 확인 후 즉시 주간에는 사회복지사, 야간에는 당직의사에게 보고하며 보고 받은 담당자는 행정부장에게 즉시 보고하고, 행정부장은 병원장에게 보고하며 성폭력의신고는 즉시 수사기관(☎112)에 신고하여야 한다.

4) 가정폭력 신고절차(가정폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 제 4조)

가) 관련법에 따라 의료기관의 종사자, 의료인 및 의료기관의 장은 직무를 수행하면서가정폭력범죄를 알게 된 경우 정당한 사유가 없으면 주간에는 사회복지사, 야간에는 당직의사에게 보고하며 보고 받은 담당자는 행정부장에게 즉시 보고하고, 행정부장은 병원장에게 보고하며 수사기관(☎112)에 신고하여야 한다.

**다. 지원**

1) 필수검사 및 신체검진 : 필요한 경우 담당 의료진은 학대 증거 확보를 비롯한 원내에서 필수 검사 및 신체검진을 실시할수 있으며 담당 의사의 판단에 따라 타 의료기관에서도 가능하다.

2) 정신 및 심리상담 : 학대 및 폭력피해로 인해 정신 및 심리상담이 필요한 경우 직원은 사회복지사에게 상담 을 의뢰하고 사회복지사는 위험성 평가 및 정서적 지지를 위해 [5.4 의료사회복지체계] 에 따라 상담을 실시한다.

3) 유관기관 연계 : 필요한 경우 사회복지사에게 의뢰하고 유관기관에 연계할 수 있다.

| 유 형 | 유관기관 | 연락처 |
|---|---|---|
| 아동학대 | 서울동남아동보호전문기관 | 02-474-1391 |
| 노인학대 | 중앙노인보호전문기관 | 1577-1389(24시간) |
| | 서울특별시남부노인보호전문기관 | 02-3472-1389 |
| 성폭력 | 한국성폭력상담소 | 02-338-2890 |
| | 서초성폭력상담소 | 02-599-7606 |
| | 서울남부해바라기센터 | 02-870-1700 |
| 가정폭력 | 동산가정폭력상담소 | 02-599-7646 |
| | 까리따스가정폭력상담소 | 02-2202-7806 |
| 외부 의뢰를 통해 필수검사 및 신체검진이 필요한 경우 | 삼성서울병원 | 1599-3114 |
| | 건국대학교병원 | 1588-1533 |
| | 서울아산병원 | 1688-7575 |

4) 사회사업연계 : 학대 및 폭력 피해로 의심되는 사례가 발생하면 사회복지에게 연락하고 [5.4 의료사회복지체계]에 따라 상담을 실시 하거나 유관기관에 연계할 수 있다.

## 4. 학대 및 폭력피해자 발생 시 경영진 보고 및 개선활동 수행

### 가. 경영진 보고

1) 보고자 : 학대 및 폭력 피해자 발생 시 사회복지사는 병원장에게 보고한다.

2) 보고시기 및 보고방법: 학대 및 폭력 피해자 발생 즉 시 병원장에게 구두로 보고하며 수사기관에게 보고 후 5일 이내에 학대 및 폭력피해자 발생 보고서를 작성하여 병원장에게 서면으로 보고한다.

### 나. 개선활동 수행

1) 보고된 학대 및 폭력피해 사고는 병원운영위원회에서 개선활동 방안을 마련하고 사회복지사는 개선계획을 수립하여 개선활동을 수행한다.

## 5. 학대 및 폭력예방 활동

### 가. 환자 피부상태 관찰

1) 학대 및 폭력예방을 위해 환자의 피부상태를 관찰한다.

가) 외래 환자인 경우 : 외래 진료 의사는 외래 환자의 초진 및 재진 시 육안으로 피부 상태를 관찰하고 학대 및 폭력 의심이 보여 질 경우 문진을 통해 확인후 경과기록지에 기록한다.

나) 입원 환자인 경우 : 입원 시 입원 병동 간호사는 간호 초기평가 시 육안으로 피부상태를 관찰하고 환의로 환복 및 욕창 유무를 확인할 때 피부 상태를 관찰하며 간호기록에 기록한다, 만약 학대 및 폭력 의심이 보여 질 경우 문진을 통해 확인한다.

(1) 65세 이상의 노인은 정기적으로 월1회 관찰하여 환자 피부상태 관찰일지에 이를 기록한다.

(2) 그 외 환자는 학대 및 폭력 의심이 보여질 경우 피부 상태를 관찰한다.

나. 지표 모니터링

1) 지표명 : 학대 및 폭력 피해 발생 보고율
(학대 및 폭력 피해 발생 보고건수/총 재원일수(모니터링 기간 일일 재원환자 합한수)X1,000)
2) 정의 : 1,000재원일당 학대 및 폭력 피해 발생 보고 건수의 비율
3) 분자 : 학대 및 폭력 피해 발생 보고 건수
4) 분모 : 총 재원 일수(반기별 일일 재원환자 수를 모두 합한 수)
5) 자료출처 : 학대 및 폭력 피해 발생 보고서
6) 조사 방법 : 반기별 학대 및 폭력 피해 발생 보고 전체 건수
7) 목표 값 설정 : 전년도 학대 및 폭력 피해 발생 보고율을 분석하여 당해 연도의 목표 값 설정

## 6. 학대 및 폭력 대응체계 및 예방활동에 관한 직원 교육

가. 교육 대상자

1) 직원은 연 1회 이상 학대 및 폭력 대응체계 및 예방활동에 관련된 교육을 실시한다.
2) 간병인 또는 위탁업체 직원은 연 1회 이상 교육을 시행하였는지 확인한다.
가) 위탁업체는 업체 계약 시 의료기관에서 요구하는 학대 및 폭력 관련 교육 이수 요건을 충족할 것을 조항으로 넣거나 본원에서 교육을 진행 및 지원하여 이수 할 수 있다.
3) 간병인(환자(또는 보호자)가 직접 계약)
가) 환자 또는 보호자가 직접 계약한 간병인이 병원에 상주할 경우 병원에서 제공한 안내문을 통하여 정보를 제공한다.

나. 교육 내용

1) 교육 내용
가) 노인학대 예방 및 신고의무에 관한 법령
나) 노인학대 발견 시 신고요령
다) 피해노인 보호절차
라) 예방 활동 내용 등
2) 교육 시간 및 교육 방법
가) 연 1회 1시간 이상 집한 교육 또는 인터넷 강의 등으로 실시 할 수 있다.

## 7. 환자 및 보호자에게 신고절차 안내(안내문 배포 게시물 부착 등)

가. 아동학대, 노인학대, 성폭력, 가정폭력 등의 신고절차는 안내문을 제작하여 원무과에 비치하여 환자 및 보호자에게 배포하고 원내 게시판의 게시물로 부착하여 안내한다.

## 8. 거동이 불편한 환자의 편의를 위한 시설 구비 및 지원

가. 주 출입구

1) 주 출입구 또는 접근로에 경사로를 설치하여 접근이 용이 하도록 하고 바닥 표면은 잘 미끄러지지 아니하는 재질로 평탄하게 마감한다. 또한, 바닥의 문턱이나 높이차이를 2cm 이하로 제거 하여 이동이 용이 하도록 한다.
2) 휠체어사용자가 통행할 수 있도록 접근로의 유효폭은 1.2m 이상으로 한다.

나. 장애인전용 주차구역

1) 장애인전용 주차구역은 장애인등의 출입이 출입구의 와 가장 가까운 장소에 설치한다.
2) 장애인전용 주차구역의 바닥면과 주차구역선에는 운전자가 식별하기 쉬운 색상으로 장애인 전용 표시를 하여야 한다.
3) 장애인전용주차구역 안내표지는 주차장 안의 식별하기 쉬운 장소에 부착하여 설치한다.

**다. 출입구(문)**

1) 출입구(문)은 통과유효폭을 0.9m 이상으로 하고 출입구의 바닥면에는 문턱이나 높이차이를 두어서는 안된다.
2) 미닫이문은 가벼운 재질로 하며, 턱이 있는 문지방이나 홈을 설치 하지 않는다.
3) 여닫이문에 도어체크(열림버튼)를 설치하는 경우 문이 닫히는 시간이 3초 이상 충분하게 확보 되도록 하여야 한다.
4) 건축물 주출입구의 전면에는 문의 폭만큼 점형블록을 설치하거나 시각장애인이 감지할 수 있도록 바닥재의 질감 등을 달리 하여야 한다.

**라. 복도, 계단 또는 승강기**

1) 휠체어 이동 가능한 유효폭은 1.2m 이상으로 하되, 복도 양옆에 거실이 있는 경우 1.5m이상으로 한다.
2) 복도의 바닥면에는 높이차이를 두어서는 안된다.
3) [장애인복지법] 제 58조, [의료법] 제 3조에 따른 병원급 의료기관은 복도 양측면에는 손잡이를 연속하여 설치하여야 한다. 다만, 방화문 등의 설치로 손잡이를 연속하여 설치할 수 없는 경우에는 그 부분에 한하여 설치 하지 않을수 있다.
4) 손잡이의 양끝부분 및 굴절부분에는 점자표지판을 부착해야 한다.
5) 계단의 유효폭은 1.2m 이상으로 하여야 한다.
6) 디딤판의 너비는 0.28m 이상, 챌면이 높이는 0.18m 이하로 하되, 동일한 계단에서 디딤판의 너비와 챌면의 높이는 균일하게 하여야 한다.
7) 계단의 양측면에는 손잡이를 연속하여 설치하여야 한다. 다만, 방화문 등의 설치로 손잡이를 연속 설치 할수 없는 경우 그 부분만큼 설치하지 아니할수 있다.
8) 계단 손잡이의 양 끝부분 및 굴절부분에는 층수·위치 등을 나타내는 점자표지 판을 부착하여야 한다.
9) 장애인용 승강기는 장애인등의 접근이 가능한 통로에 연결하여 설치하되, 가급적 출입구와 가까운 위치에 설치하여야 한다.
10) 장애인용 승강기 내부의 유효바닥면적은 폭 1.1m 이상, 깊이 1.35m 이상으로 하여야 한다. 다만, 신축 건물일 경우 1.6m 이상으로 하여야 한다.
11) 호출버튼·조작반·통화장치 등 승강기의 안팎에 설치되는 모든 스위치의 높이는 0.8이상 1.2m 이내에 설치한다.
12) 조작설비의 형태는 버튼식으로 하되, 시각장애인 등이 감지할 수 있도록 층수 등을 점자로 표시하여야 한다.

**마. 화장실(대변기, 소변기, 세면대)**

1) 화장실의 0.3m 전면에는 점형블록을 설치한다.
2) 화장실의 출입구(문) 옆 벽면의 1.5m 높이에는 남자용과 여자용을 구별할 수 있는 점자표지판을 부착하고, 출입구(문) 통과유효폭은 0.9m 이상으로 하여야 한다.
3) 대변기는 등받이가 있는 양변기형태로 한다.

4) 대변기 양옆에는 수평 및 수직 손잡이를 설치 하도, 수평손잡이는 양쪽에 모두 설치하여야 하며, 수직손잡이는 한쪽에는 설치할 수 있다.
5) 출입문에는 화장실 사용여부를 시각적으로 알수 있는 설비 및 잠금 장치를 갖추어야 한다.
6) 화장실 내에서 비상사태를 대비하여 비상용 벨은 대변기 가까운 곳에 0.6m와 0.9미터 사이의 높이에 설치하되, 바닥면으로부터 0.2m 내외 높이에서 이용이 가능하도록 하여야 한다.
7) 소변기는 양옆에 수평 및 수직 손잡이를 설치하여야 한다.
8) 세면대의 하부는 무릎 및 휠체어의 발판이 들어갈수 있도록 하여야 한다.
9) 수도꼭지는 냉·온수의 구분을 점자로 표시하여야 한다.

## ▣ 부록 (Appendix)

1. 취약환자 지원체계
2. 학대(노인학대) 및 폭력피해자(성폭력. 가정폭력) 신고절차
2. 취약환자 상담일지
3. 취약환자 접수대장

## ▣ 규정 개정일 [누적]

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 승 인 책 임 자 | 병 원 장 | 이름 | | 서명 | |
| 승 인 일 | . . . | | | | |

# 취약환자 지원체계

## 취약환자 지원체계

| | |
|---|---|
| 의사소통 어려운 환자<br>(청각, 언어, 시각) | ■ 구화(입 모양), 종이 필기도구 사용하여 소통<br>■ 주간: 사회복지과 ☎070-5150-9327<br>■ 야간: 당직의, 당직자 ☎010-7797-5114<br>■ 응급 시: 유관기관 |
| 응급 시 환자이송 | ■ 삼성서울병원: ☎1599-3114<br>■ 건국대학교병원: ☎1588-1533<br>■ 서울아산병원: ☎1688-7575 |
| 유관기관 안내 | ■ 서울동남아동보호전문기관 : ☎02-474-1391<br>■ 중앙노인보호전문기관: ☎1577-1389(24시간)<br>■ 여성긴급전화1336 서울센터 1366 서울센터: ☎02-851-4870<br>■ 서울특별시 장애인권익옹호기관: ☎1644-8295<br>■ 서울특별시 농아인 협회 통역센터: ☎02)323-4996)<br>■ 서울특별시 시각장애인복지관: ☎02)422-8108)<br>■ 전문통역 BBB코리아: ☎1588-5644<br>■ 일원지구대: ☎ 02)2155-9309 |

## 장애 환자 편의시설 안내

| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 휠 체 어 | 1층 원무과, 각 병동마다 휠체어 비치 |
| 장애인 전용 화장실 | 1층 장애인 전용 화장실 운영 |
| 장애인 전용 주차장 | 지하 1층 운영 |
| 콜 벨 | 장애 환자의 안전을 위하여 응급 상황 시 호출할 수 있는 벨 (병실 침상 위, 화장실 부착) |

부록2. 학대(노인학대) 및 폭력피해자(성폭력,가정폭력) 발생시 신고절차

# 학대(아동, 노인) 및 폭력피해자(성폭력, 가정폭력) 발생 시 신고절차

## 학대(노인학대) 및 폭력 피해자(성폭력, 가정폭력) 발생 시 신고 절차

| 학대<br>(아동학대, 노인학대) | 성폭력 | 가정폭력 |
|---|---|---|

↓

관계법령에 따라 누구든지 학대 및 폭력피해 사실을 알 경우 관련 기관 및 수사기관에 신고

↓

| 유 형 | | 신고기관 | 신고번호 |
|---|---|---|---|
| 학대 | 아동학대 | 아동보호전문기관 | 062-385-1391 |
| | 노인학대 | 중앙노인보호전문기관 | 1577-1389 |
| | | 경찰서 | 112 |
| 성폭력 | | 경찰서 | 112 |
| 가정폭력 | | 경찰서 | 112 |

※직접 신고가 어려우신 경우 병원 직원에게 알려주시기 바랍니다※

## 학대(아동학대, 노인학대) 및 폭력(성폭력, 가정폭력)의 의심 사례

| 유 형 | 내 용 |
|---|---|
| 학대<br>(아동학대, 노인학대) | ▷여러상처가 보이는 경우<br>▷오래된 상처가 보이는 경우<br>▷보살핌이 미뤄지는 경우<br>▷환자가 학대를 받음을 인정하는 경우 |
| 성폭력 | ▷머리, 목, 몸통, 배, 가슴이나 생식기에 입은 상처<br>▷고민, 우울, 불안, 자살충동, 불면증이 보이는 경우<br>▷이성이 옆에 있을 경우 불안한 증세(몸짓, 말투 등) |
| 가정폭력 | ▷다수의 상처들 혹은 반복되는 입원<br>▷상처와 일치하지 않은 환자의 상황설명<br>▷임상부의 상처(특히, 가슴 혹은 배)<br>▷과잉보호나 이야기 중 환자의 옆을 떠나지 않으려고 하는 배우자 |

부록3. 취약환자 상담일지

# 취약환자 상담일지

20 년 월 일

| 결재 | 담 당 | 부서장 | 병원장 |
|---|---|---|---|
| | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 환 자 명 | | 접 수 번 호 | |
| 나이 / 성별 | | 병 실 | |
| 상담 접수자 | | 환자와의 관계 | |
| 접수 일자 | 20 년 월 일 | | |
| 상담 일시 | 20 년 월 일 | | |
| 상담 형태 (장소) | | | |
| 의뢰 사유 | □ 정서적 학대<br>□ 신체적 학대<br>□ 방임<br>□ 경제적 학대<br>□ 신체, 시각, 청각, 언어장애 | | |
| 상담 내용 | | | |
| 의 견 | | | |
| 행정 절차 | □ 본원에서 자체해결<br>□ 응급시(타병원, 112신고)<br>□ 타 기관 연계(노인학대예방센터, 장애인차량 등) | | |
| 결 과 | □ 사례종결 □ 사례평가 □ 사후관리 | | |

부록4. 취약환자 접수대장

# 취약환자 접수대장

(20 년)

| 접수 번호 | 접수 일자 | 지원요청인 | | 취약환자지원 접수내용 | 행정절차 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 성 명 | 병실 | | |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |